המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association
חינוך רפואי זו ההתמחות שלנו

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואה פנימית

15.10.2024

מס' השאלות : 100

בחינת שלב א' רפואה פנימית 15.10.24

1. בן 59 מאובחן עם מחלה ראומטולוגית. מתקבל לחדר מיון בתמונה של חום 39°C, תת לחץ דם ונראה חולה. בבדיקות הדם CRP - 0. איזו תרופה שמקבל המטופל יכולה לגרום לכך?

   א. Tocilizumab
   ב. Adalimumab
   ג. Abatacept
   ד. Rituximab

2. בן 55, מוצא הודי, מאושפז בתמונה של מיימת חדשה ובצקת פריפרית. בבדיקתו ללא גודש ריאתי, JVP מוגבר בישיבה. אקו לב EF- 60%, חדר ועליה ימין בגודל ותפקוד תקינים, ללא יתר לחץ דם ריאתי וללא נוזל פלאורלי. בניקור מיימת SAAG - 1.4 ותכולת חלבון 2.9 גרם/ד"ל בנוזל. בצנתור המודינאמי לחצי מילוי סוף דיאסטוליים בחדרי הלב זהים. מה צפוי למצוא בבדיקת MRI לב?

   א. עיבוי דיפוזי של דופן שריר הלב
   ב. האדרה מאוחרת בדופן החדר הימני
   ג. עיבוי פריקרדיאלי
   ד. הסתיידויות מיוקרדיאליות

3. בן 20 מתאשפז בשל ערכי סוכר עד 300 מ"ג/ד"ל ללא קטואצידוזיס. מדווח על פוליאוריה ופולידיפסיה בחודשים האחרונים אבל ללא ירידה במשקל. איזו מחלה יכולה להסביר בסבירות גבוהה את ערכי הסוכר שנמדדו?

   א. VIPoma
   ב. Hypothyroidism
   ג. Hypogonadism
   ד. Acromegaly

4. מה מהבאים נכון לגבי אבחנת דליריום?

   א. הפרעה בקשב נדרשת לאבחנה
   ב. הפרעה פלוקטואטיבית לא נדרשת באבחנה
   ג. שינוי במצב הכרה נדרש באבחנה
   ד. הפרעה בחשיבה קוהרנטית נדרשת באבחנה

5. בן 58, מושתל כבד, מאושפז בשל מחלת חום, עייפות וכאב ראש מזה 3 שבועות. בבדיקתו, בין השאר, הממצא הנראה **בתמונה 1**. מה הטיפול המומלץ?

   א. Piperacillin-tazobactam
   ב. Penicillin
   ג. Amphotericin B
   ד. Acyclovir

6. בת 35, מתלוננת על כאבים ברום הבטן מזה כחצי שנה, תבחין נשיפה ל-*Helicobacter pylori* שלילי. שוללת נטילת NSAIDs. גסטרוסקופיה מדגימה כיב בחלק השלישי של התריסריון. מה הכי נכון לגבי המשך ניהול המקרה?

   א. יש לתת proton pump inhibitors (PPI) ולבצע מעקב
   ב. יש להשלים בדיקת אנטיגן ל- *Helicobacter pylori* בצואה
   ג. יש לבדוק רמת gastrin בדם
   ד. יש לבדוק נוגדנים ל- tissue transglutaminase (anti-TTG)

7. בן 49, פונה למלר"ד בשל שבועיים ירידה ביכולת ביצוע מאמצים, כאב בטן ודימום מהאף. במעבדה לויקוציטוזיס של 150,000 עם לימפוציטוזיס של 100,000, המוגלובין 8 ג'/ד"ל וטסיות 16,000. בבירור נמצא כי סובל מ- ALL. מתחיל טיפול בסטרואידים ועולה החשד ל (tumor lysis syndrome) TLS. איזה שילוב ממצאי מעבדה תומך באבחנה?

   א. היפרקלצמיה, היפופוספטמיה, היפרקלמיה
   ב. היפוקלצמיה, היפרפוספטמיה, היפוקלמיה
   ג. היפרקלצמיה, היפופוספטמיה, היפוקלמיה
   ד. היפוקלצמיה, היפרפוספטמיה, היפרקלמיה

8. בת 68, פונה לבירור בשל החמרה בקוצר נשימה ועייפות בחודשים האחרונים. צילום חזה, בירור קרדיאלי ובדיקות מעבדה - תקינים. בתפקודי ריאות מלאים:

FEV1	55%	FRC	100%
FVC	55%	TLC	77%
FEV1/FVC	0.85	RV	130%
		DLCO	85%

איזו מבין הבדיקות הבאות תקדם בסבירות הכי גבוהה את אבחנת מחלתה של החולה?

א. Chest CT with contrast
ב. Acetylcholine receptor Ab
ג. Cardio-pulmonary test
ד. Metacholine challenge test

9. בן 62. ברקע דיסליפידמיה וסוכרת. החל לפני חודשיים טיפול בסטטינים ומטפורמין. מתקבל לבית החולים עם חולשת שרירים פרוקסימלית, הפרעת בליעה ובמעבדה ערכי CPK פי 10 מהנורמה ללא אי ספיקת כליות. באשפוז - הפסקת תרופות ומתן נוזלים במשך 7 ימים לא הביאו לשיפור. מה הצעד הבא בטיפול בחולה זה?

א. טיפול אימונוסופרסיבי אגרסיבי
ב. דיאליזה
ג. Plasma exchange
ד. המשך טיפול שמרני ע"י נוזלים

10. בן 42 סובל מאירועים חוזרים של הזעה ורעד המופיעים בעיקר בשעות הבוקר וחולפים לאחר שאוכל מתוק. בעצת רופאו מתאשפז לבירור ועם הופעת התסמינים נמדדים ערכי גלוקוז של 32 מ״ג/ד״ל. במקביל נלקחות רמות אינסולין ו-C peptide שחוזרות בטווח הנורמה ורמות נמוכות של קטונים בדם. איזו מבין הבאים היא הסיבה הסבירה ביותר למצב המתואר?

א. הזרקה של אינסולין
ב. גידול מזנכימלי מפריש IGF2
ג. נטילת sulfonylureas
ד. נטילת SGLT2 inhibitors

11. איזו היצרות קרוטידית מבין הבאות היא בעלת הסיכון הנמוך ביותר להתפתחות אירוע מוחי?

א. היצרות של 80% של העורק הקרוטידי הימני בחולה שעבר אירוע מוחי קודם שביטויו חולשת פלג גוף שמאל
ב. היצרות של 99% של העורק הקרוטידי השמאלי בחולה ללא היסטוריה של אירוע מוחי
ג. היצרות של 85% של העורק הקרוטידי הימני בחולה עם אירוע מוחי קודם שביטויו אפזיה סנסורית
ד. היצרות של 70% של העורק הקרוטידי השמאלי בחולה ללא היסטוריה של אירוע מוחי

12. איזו מהתרופות הבאות יכולה למנוע התפתחות של nephrogenic diabetes insipidus בחולים המטופלים בליתיום?

א. Thiazide
ב. Amiloride
ג. Furosemide
ד. Aldospirone

13. בן 65 אובחן לאחרונה כסובל מזיהום ע״י *Nocardia* והחל טיפול אנטיביוטי קו ראשון כמקובל. איזו בדיקה ראוי לבצע באופן תקופתי?

א. אק״ג
ב. ריכוז אשלגן בדם
ג. בדיקת שמיעה
ד. בדיקת עיניים

14. בן 30 פנה למלר"ד עקב כאבים לוחצים בחזה שהחלו לאחר כיומיים בהם סבל מחום ונזלת. מדדים במלר"ד: ל"ד 130/70, דופק 100 לדקה, סטורציה תקינה, חום 39°C. בבדיקתו רושם לאודם בגרון, אין סימני אי ספיקת לב, בדיקת הריאות תקינה. אק"ג פוענח כתקין. במעבדה: טרופונין 1000 בשתי בדיקות עוקבות. מה הטיפול הנכון ביותר כעת?

א. אספירין ו P2Y12 inhibitor
ב. סטרואידים תוך ורידיים
ג. אנטיביוטיקה
ד. טיפול תומך בלבד

15. בן 68, ברקע יתר לחץ דם, היפרליפידמיה וסוכרת סוג 2 הידועה כ 16 שנה. לפני 8 שנים עבר אירוע מוחי. טיפול תרופתי לסוכרת כולל: אינסולין בזאלי 24 יחידות בערב, (metformin+sitagliptin) januet במינון 50/1000 מ"ג פעמיים ביום. ערכי סוכר בבית בצום בשעות הבוקר 65-80, שעתיים אחרי אוכל 180-200. במעבדה - המוגלובין מסוכרר 7.1%, GFR-35 מ"ל/דקה ל1.73 מ^2 , BMI-27 kg/m^2. מה נכון לגבי המשך הטיפול בסוכרת במטופל זה?

א. אין צורך לשנות טיפול
ב. יש להעלות מינון אינסולין בזאלי
ג. חובה להפסיק טיפול ב- sitagliptin
ד. יש להפחית מינון אינסולין בזאלי ומינון januet

16. למי מהמטופלים הבאים עם עליית קריאטינין מ-1 מ"ג/ד"ל ל-1.5 מ"ג/ד"ל צפוי FENa>1% ?

א. מטופל אשר עבר צנתור אלקטיבי לפני 3 ימים
ב. מטופל אשר אושפז בשל רבדומיוליזיס
ג. מטופל לאחר 5 ימי טיפול ב- amikacin
ד. מטופל אשר התקבל בתמונה של STEMI ושוק קרדיוגני

17. בן 35 בריא בדרך כלל. במסגרת תרומת דם נבדקה סרולוגיה ל- HBV ונמצאו הממצאים הבאים : HBsAg חיובי, HBeAg שלילי, anti HBc חיובי, anti HBe חיובי, HBV DNA 1200 IU/ml. אנזימי כבד תקינים. כיצד יש לטפל בו?

א. אין צורך בטיפול אנטי ויראלי
ב. ניתן לתת טיפול אנטי ויראלי ב- NUC'S (nuclear analogs) או ב- PEG-Interferon לפי העדפת המטופל
ג. יש לטפל ע"י PEG-interferon
ד. יש לטפל ע"י NUC'S

18. איזה מהצמדים הבאים מתאר הכי נכון את הקשר בין גורם סיכון אפידמיולוגי לבין פתוגן אפשרי כמחולל בדלקת ריאות שנרכשת בקהילה?

א. חשיפה לציפורים - *Coxiella burnetii*
ב. אלכוהוליזם – *Klebsiella Pneumonia*
ג. מחלת ריאות מבנית – *Fusobacterium* spp
ד. מחלה ריאתית חסימתית כרונית – *Mycoplasma pneumonia*

19. בן 63, מעשן כבד. פונה לבירור בשל החמרה בקוצר נשימה בחודשים האחרונים. תפקודי ריאה מזה כשנתיים יציבים עם FEV1 22% מהצפוי, FVC 78% מהצפוי , FEV1/FVC 0.45, ללא שינוי אחרי מרחיבי סמפונות, DLCO 34% מהצפוי. BMI – 32, ב- CT חזה בולות גדולות, בספירת דם אאוזינופיליה. איזה מהבאים הוא הגורם הפרוגנוסטי הגרוע ביותר?

א. ה- FEV הירוד
ב. הבולות גדולות ב CT חזה
ג. עודף המשקל
ד. האאוזינופיליה

20. איזה מהמצבים הבאים מהווה אינדיקציה לטיפול מונע לאנדוקרדיטיס סביב טיפולי שיניים?

א. ASD שלא עבר תיקון
ב. Hypertrophic cardiomyopathy
ג. מצב לאחר TAVI
ד. קוצב קבוע

21. מה נכון לגבי סיבוכים אפשריים של זיהום חד ב- EBV?

א. עלולה להתפתח תסמונת מיאלודיספלסטית
ב. קרע בטחול מתפתח בכ- 10% מהחולים
ג. עלול להיות מלווה ב- hemophagocytic lymphohistiocytosis
ד. הסיבוכים הנוירולוגים מופיעים לרוב לאחר 8 שבועות

22. בת 73, נשלחת לבירור בשל תלונות על ירידה בתחושה בחלקים הדיסטלים של שתי הרגליים ורמות מוגברות של RF, ללא תלונות נוספות. מבין האבחנות הבאות מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. Rheumatoid arthritis
ב. Cryoglobulinemia
ג. Endocarditis
ד. IgA vasculitis

23. למי מהמטופלים הבאים הסובלים מפרפור עליות **אין** לתת טיפול אנטיקואגולנטי?

א. מטופל עם היסטוריה של אירוע מוחי המורגי לפני שנה
ב. מטופל עם CAA (cerebral amyloid angiopathy)
ג. מטופל עם ITP וספירת טרומבוציטים של 60,000
ד. מטופל שחמתי עם טרומבוזיס של הוריד הפורטלי

24. בן 61, ברקע אסתמה, מאושפז עקב חום סובפיברילי מזה 3 שבועות, חולשה ונימול ביד ימין. בבדיקה פריחה ע"פ הגפיים התחתונות (תמונה 2). בצילום חזה תסנינים עדינים דו"צ, יותר בפסגות. במעבדה לויקוציטוזיס 14,000 עם 75% ניוטרופילים, 15% לימפוציטים ו10% אאוזינופילים, קריאטינין 1.4 מ"ג/ד"ל מבסיס תקין ו CRP 10 (נורמה עד 0.5).
לאור הרקע והממצאים הנלווים מה מהבאים נכון בהתייחס לטיפול למחלתו?

א. נצפה לראות בכמחצית מהמטופלים תגובה טובה לסטרואידים
ב. התלקחות במטופלים שהגיבו לטיפול - נדירה
ג. אם אין תגובה לטיפול בסטרואידים ניתן להוסיף anti TNF
ד. טיפול ב- anti IL5 הוכח כמפחית התלקחויות

25. בת 64, פונה עקב שיעול טורדני מזה חודש מלווה בארטריטיס וחום סבפיברילי. בסיטי חזה **(תמונה 3)** ממצאים של לימפאדנופתיה מדיאסטינאלית והילארית דו"צ והצללות נודולריות ופריברונכווסקולריות יותר באונות עליונות. בבירור שבוצע נשלל מחולל זיהומי. בביופסיה טראנס-ברונכיאלית נמצאו גרנולומות ללא נמק. מה הטיפול המומלץ כעת?

א. אין צורך בטיפול תרופתי סיסטמי
ב. prednisone במינון של 40 מ"ג בשילוב steroid sparing agent
ג. prednisone במינון 20 מ"ג
ד. IV methylprednisolone 1000 mg למשך 3 ימים

26. בת 37, עולה מאורוגוואי, פונה בשל המופטיזיס הולך וגובר בשבועיים האחרונים. בבדיקה נראית חולה. במעבדה המוגלובין 10 ג"/ד"ל, נורמוציטית נורמוכרומית, CRP מוגבר. מצורף צילום חזה **(תמונה 4)**: איזו מהבדיקות הבאות היא **לא** צעד אבחנתי מתאים בחולה זו?

א. בדיקת PCR מכיח
ב. בדיקת תרבית משטיפה ברונכיאלית
ג. בדיקת Tuberculin skin testing
ד. צביעת acid-fast מכיח

27. איזה ממצא בניקור מותני **הכי** אופייני במנינגיטיס חיידקית?

א. ריכוז חלבון – 40 mg/dl
ב. ריכוז גלוקוז – 80 mg/dl
ג. מס' אריתרוציטים – 250/µL
ד. לחץ פתיחה של – 200 mmH_2O

28. בן 78, אושפז בשל הקאה דמית המתוארת כ- "Coffee ground", ברקע מחלת לב איסכמית וסוכרת. מטופל ב- metformin ואספירין. בגסטרוסקופיה - כיב פפטי, בדיקה לנוכחות הליקובקטר פילורי - שלילית. מה ההמלצות להמשך הטיפול בחולה זה?

א. המשך טיפול באספירין והתחלת טיפול ב-(PPI) proton pump inhibitors
ב. המרת הטיפול מאספירין ל- clopidogrel ללא PPI
ג. הפסקת טיפול באספירין ומתן PPI
ד. המרת הטיפול מאספירין ל- clopidogrel והוספת PPI

29. מטופלת כבת 50 מגיעה למרפאה לצורך איזון לחץ דם. איזה מהממצאים הבאים, **הכי** מחשיד כי המטופלת סובלת מיתר לחץ דם שניוני?

א. לחץ הדם ידוע כבר מעל 3 שנים
ב. עובי ספטום בין חדרי של 15 מ"מ לפי בדיקת אקו לב
ג. חוסר איזון למרות טיפול בשילוב של שתי תרופות
ד. ערכי לחץ דם סיסטולים מעל 150 מ"מ כספית

30. מה נכון לגבי היפוקלמיה?

א. אם ממושכת עלולה לגרום לפגיעה טובולרית קשה
ב. מקטינה את הסיכון ל-digitals toxicity
ג. עלולה לגרום לשינויי אק"ג בתבנית ברוגדה
ד. עלולה לגרום ל- SIADH

31. בת 60, עולה חדשה מאוקראינה, BMI 29, פונה לבירור בגלל מיימת חדשה ובצקות בגפיים. אולטראסאונד בטן ללא ממצא ראוי לציון למעט מיימת. באשפוז מנוקזים 3 ליטרים של נוזל צלול.
במעבדה: אלבומין בדם 3.6 gr/dl, אלבומין בנוזל המיימת 2.2 gr/dl, חלבון בנוזל המיימת 3 gr/dl. מה הסיבה הסבירה ביותר למיימת של המטופלת?

א. שחפת
ב. אי ספיקת לב
ג. שחמת
ד. ממאירות

32. מה נכון לגבי הטיפול ב-severe alcoholic hepatitis?

א. מתן prednisone במינון של 40 מ״ג יעיל במניעת תמותה ארוכת טווח
ב. Lille score מאפשר לקבוע יעילות תגובה ומשך טיפול בסטרואידים
ג. דליות בושט הן קונטראינדיקציה לטיפול בסטרואידים
ד. למטופלים שלא מגיבים תוך 7 ימים לטיפול בסטרואידים יש להכפיל את המינון

33. בת 45, מתלוננת על קוצר נשימה ושיעול מזה 6 חודשים. בנוסף: כאבי מפרקים בידיים עם נוקשות בוקר, הלבנת האצבעות בקור, קושי להסתרק וקושי לעלות מדרגות. בבדיקת הריאות נשמעות קרפיטציות, ובידיים סדקים וחספוס ללא נוקשות עורית. בדיקת CT חזה מצ״ב **(תמונה 5)**. איזו מבין בדיקות המעבדה מהבאות הכי סביר שתהיה חיובית?

א. Anti-JO1
ב. Anti-dsDNA
ג. Anti-HMG co-reductase
ד. Anti SSa

34. בן 18 מובא למלר"ד כ-8 שעות לאחר נטילת 6 גרם paracetamol. בבדיקתו יציב וא-תסמיני, במעבדה ALT/AST בתחום הנורמה. רמת paracetamol 150 מיקרוגרם/מ״ל (מצ״ב גרף **בתמונה 6**). מה יכלול המשך ניהול המקרה?

א. שחרור המטופל והמשך מעקב אמבולטורי
ב. מתן פחם פעיל
ג. מתן N-acetylcysteine
ד. יש לחזור על בדיקת רמות התרופה בעוד 4 שעות על מנת להחליט על המשך הטיפול

35. בת 65, ברקע ממאירות שד גרורתית מטופלת בכימותרפיה. אושפזה בשל חום ונויטרופניה ללא מקור ברור. איזה מהטיפולים הבאים הוכח כמפחית אחוזי תמותה?

א. IV ertapenem
ב. IV amikacin
ג. S.C. GCSF
ד. IV ceftazidime

36. להלן תוצאות בדיקות המעבדה של בן 49 מטופל המודיאליזה:
אלבומין 3.8 ג/ד"ל, זרחן 6.8 מ"ג/ד"ל, סידן 7.9 מ"ג/ד"ל, PTH 200 פיקוגרם/מ"ל
(ערכי נורמה 30-76)
איזה טיפול קו ראשון יש להתחיל בחולה זה?

א. Calcitriol
ב. Calcium Carbonate
ג. Sevelamer
ד. Cinacalcet

37. בן 86 התקבל למלר"ד עקב כאבים בחזה ועליית ערכי טרופונין על רקע אוטם בשריר הלב. הוא מועמד לצנתור קורונרי אך חושש לעבור את הפרוצדורה כי בגיליון הרפואי שלו מסומן "אלרגיה ליוד". איזה מבין הגורמים הבאים מעלה באופן המשמעותי ביותר את הסיכון לתגובה אלרגית לחומר הניגוד שיוזרק במהלך הצנתור?

א. תגובה קודמת לחומר ניגוד רנטגני המכיל יוד
ב. תגובה קשה לחומר חיטוי המכיל יוד
ג. תגובה אנאפילקטית למאכלי ים עם אשפוז בטיפול נמרץ
ד. אובדן הכרה לאחר הזרקת יוד רדיואקטיבי

38. בן 45 מאובחן עם Marfan syndrome ולא היה במעקב רפואי. פונה כעת למרפאה בעקבות תלונות על אי סבילות למאמצים ומספר שנאמר לו בעבר ששורש האאורטה רחב. בבדיקתו נשמעה אוושה דיאסטולית.
איזה מבין הממצאים הבאים יצביע על מחלה מסתמית חמורה במטופל זה?

א. לחץ דם דיאסטולי גבוה
ב. אוושה קצרה
ג. היעלמות מרכיב A2 בקול השני
ד. התעצמות איטית של הדופק

39. בן 47 עם שחמת כבד אלכוהולית, מתייצג עם המטמזיס. בבדיקה פיזיקלית נמצאים צהבת בלחמיות, מיימת וספלנומגליה. בדיקות מעבדה כדלקמן:
המוגלובין – 8.5 ג'/ד"ל, טסיות – 19,000, לויקוציטים- 8000.
תפקודי קרישה: INR-1.5, aPTT – 40s (25-37s), fibrinogen – 140 mg/dl
איזה מבין הטיפולים הבאים הוא הטיפול **הראשון** אותו יש לתת לחולה זה?

א. DDAVP
ב. FFP
ג. Packed cells
ד. Platelets

40. בת 25, מתלוננת על שלשול, במעבדה אנמיה של חסר ברזל. בדיקת IgA תקינה, ערכי anti-tissue transglutaminase גבוהים. בגסטרוסקופיה - בביופסיה מהתריסריון השטחה של ה-villi והסננה לימפוציטרית אינטרא-אפיתליאלית. הומלץ על דיאטה נטולת גלוטן. לאחר כשנה עדיין תלונות על שלשול ללא שינוי, סרולוגיה שלילית וביופסיה חוזרת תקינה. מה הצעד הבא המומלץ בניהול המקרה?

א. יש להפנות להדרכה חוזרת של דיאטנית
ב. יש להשלים בדיקת אנטיגן בצואה ל- *H. pylori*
ג. ניתן לחזור לדיאטה רגילה מכיוון שהאבחנה של צליאק לא נכונה
ד. יש לשקול ביצוע קולונוסקופיה להמשך הבירור

41. בת 70 מאובחנת כבר שנים רבות עם היפרפאראתירואידיזם במהלכן סירבה לניתוח. כעת מתייצגת עם רמת סידן של 13מ"ג/ד"ל ו- PTH מוגבר. מסכימה לבסוף לניתוח. מבוצע US ומיפוי לדיוק מיקום הבלוטה. לאחר הניתוח נמדדו ערכי סידן 7 מ"ג/ד"ל וערכי זרחן 1.5 מ"ג/ד"ל. מה הסיבה הסבירה ביותר לערכים אלו?

א. Postoperative hypoparathyroidism
ב. Hungry bone syndrome
ג. Vitamin D deficiency
ד. Mg deficiency

42. בקטרמיה של איזה מסוגי הסטרפטוקוקים הבאים תחשיד לאנדוקרידיטיס בסבירות הגבוהה ביותר?

א. S. *mutans*
ב. S. beta- hemolytic group A
ג. S. *agalactiae*
ד. S. *pneumonia*

43. איזה זיהום חיידקי בדם (בקטרמיה) קשור לממאירות בשכיחות יתר?

א. *Streptococcus anginosus*
ב. *Klebsiella pneumoniae*
ג. *Clostridium septicum*
ד. *Fusobacterium* spp

44. בת 64 עם rheumatoid arthritis סרופוזיטיבי מזה שנים רבות, וכישלון של מספר קווי טיפול. קיבלה המלצה על טיפול ב- rituximab. איזה בירור הכרחי לבצע טרם התחלת טיפול זה?

א. בדיקת מנטו (PPD) לשחפת לטנטית וצילום חזה
ב. סרולוגיה מלאה להפטיטיס B כולל HBsAg, HBcAb, HBsAb
ג. בדיקת קריאטינין וחישוב CCT
ד. בדיקת רמת IgA בדם

45. איזו מהמחלות האוטואימוניות הבאות מהווה את גורם הסיכון <u>המשמעותי ביותר</u> להתפתחות לימפומה?

א. Rheumatoid arthritis
ב. SLE
ג. Crohn`s disease
ד. Sjogren syndrome

46. בן 81 עם דמנציה מאובחנת, מאושפז במחלקה פנימית לאחר אירוע של פרה-סינקופה. מטופל דרך קבע ב donepezil (cholinesterase inhibitor). במהלך האשפוז מפגין אי שקט ניכר. בהנחה שאין גורמים הפיכים לאי השקט של המטופל, כיצד ניתן לטפל בו?

א. יש להפסיק את הטיפול ב- donepezil
ב. ע"י בנזודיאזפינים במינון נמוך
ג. ע"י Quetiapine
ד. יש להחליף את הטיפול מ- donepezil ל- memantine

47. מה יש לעשות כאשר חולה פונה למלר"ד עם תלונות על כאבים בחזה ותמונת האק"ג הבאה **(תמונה 7)**?

א. Primary PCI
ב. Head CT
ג. CTA of aorta
ד. Echocardiography

48. בן 32, בריא בד"כ, משקל 80 ק"ג, פונה למלר"ד בשל תלונות על כאבים בחזה ב 4 הימים האחרונים. תרשים אק"ג מצ"ב **(תמונה 8)**. מה טיפול קו ראשון באבחנה הסבירה ביותר?

א. אספירין 1 ג' שלוש פעמים ביום + קולכיצין 0.5 מ"ג פעמיים ביום
ב. פרדניזון במינון 80 מ"ג ליום + קולכיצין 0.5 מ"ג פעם ביום
ג. איבופרופן 200 מ"ג שלוש פעמים ביום + קולכיצין 0.5 מ"ג פעמיים ביום
ד. אינדומטצין 25 מ"ג שלוש פעמים ביום + קולכיצין 0.5 מ"ג פעם ביום

49. למלר"ד מובא גבר בן 55 מפרכס לאחר סיום ריצת מרתון. בבדיקה לחץ דם 120/80 דופק 90, גלוקוז תקין. איזה מבין הטיפולים הבאים ישפר את מצבו של המטופל בסבירות הגבוהה ביותר?

א. ביקרבונט
ב. סליין היפרטוני
ג. סליין 0.9%
ד. מגנזיום

50. איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי בירור אתיולוגיה אפשרית במטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית (CKD) ללא אתיולוגיה נראית לעין?

א. במטופלים המגיעים לבירור ראשון כאשר הם סובלים כבר מאי ספיקת כליות סופנית ניתן ברוב המקרים להגיע לאבחנה האתיולוגית ע"י ביופסיית כליה
ב. בכל המטופלים מעל גיל 35 יש לבצע בירור ל-multiple myeloma גם בהיעדר היפרקלצמיה
ג. במטופלים הסובלים מסוכרת סוג 2, בדיקת פונדוס תקינה שוללת diabetic nephropathy
ד. במטופלים מעל גיל 50 עם כליה אחת גדולה וכליה אחת אטרופית ניתן לאבחן בוודאות שמדובר ב-renovascular disease

51. בת 62 מתקבלת למלר"ד עם קוצר נשימה, מספר שעות אחרי נטילת תרופה חדשה. בבדיקתה: חום 38.3°C, במעבדה לויקוציטוזיס ואאוזינופיליה 1300. מצ"ב צילום חזה של המטופלת (מימין צילום בסיס, משמאל צילום עדכני – **תמונה 9**). איזו מבין התרופות הבאות יכולה להוות זרז (Trigger) למצב זה בשכיחות <u>הגבוהה ביותר</u>?

א. Ibuprofen
ב. Methotrexate
ג. Amiodarone
ד. Allopurinol

52. בת 50 בריאה בדרך כלל, סובלת כ-5 ימים ממחלת חום מלווה בשיעול וליחה. בצילום חזה - תסנין מימין, במעבדה לויקוציטוזיס עם סטייה שמאלה ו CRP מוגבר. מותחל טיפול אנטיביוטי משולב בצפלוספורין דור III ומקרוליד. לאחר 3 ימים מתפתח כאב פלאוריטי עז. מצורפים צילומי חזה (**תמונה 10**) לפני (ימין) ואחרי (שמאל) ניקור פלאורלי עם יציאת 1200 סמ"ק של נוזל לא צלול. במעבדה:

Blood: Protein - 7.2g/dl, LDH- 220
Effusion: Protein- 4.2g/dl, LDH- 900
pH- 7.25, גלוקוז 67 מ"ג/ד"ל

משטח ישיר חיובי לקוקים גראם חיוביים בשרשראות. מה הצעד הבא <u>הנכון ביותר</u> בניהול המקרה?

א. הרחבת הטיפול האנטיביוטי וביצוע ניקור פלאורלי חוזר
ב. המשך אותו טיפול אנטיביוטי וביצוע ניקור חוזר
ג. המשך אותו טיפול אנטיביוטי והכנסת נקז חזה
ד. הרחבת הטיפול האנטיביוטי והכנסת נקז חזה

53. בת 89, מחלימה מניתוח תיקון שבר צוואר ירך. ללא מחלות רקע למעט CKD (eGFR – 40 ml/min) במהלך אשפוזה אובחן deep vein thrombosis בוריד הפמורלי השמאלי. איזה מבין הטיפולים הבאים (לאחר מנת העמסה) הוא המומלץ ביותר למטופלת זו?

א. rivaroxaban או apixaban במינון מלא ללא הגבלת זמן ברורה
ב. rivaroxaban או apixaban במינון מופחת ללא הגבלת זמן ברורה
ג. rivaroxaban או apixaban במינון מלא ל- 3-6 חודשים
ד. rivaroxaban או apixaban במינון מופחת ל- 3-6 חודשים

54. מה נכון לגבי טיפול ב-Auto immune hepatitis?

א. azathioprine יכול להביא לרמיסיה בדומה ל prednisone
ב. budesonide הוא תחליף טוב לprednisone במיוחד בחולים עם שחמת כבד
ג. prednisone אחת ליומיים יעיל כמו מתן יומי אך מפחית תופעות לוואי
ד. azathioprine בשילוב מינון נמוך של prednisone יעיל כמו טיפול במינון גבוה יותר של prednisone

55. להלן צמדים של תרופה לטיפול במחלת מעי דלקתית ותופעת לוואי אפשרית. איזה מהצמדים הללו אכן מתאר קשר ידוע?

א. azathioprine - לימפומה
ב. vedolizumab - פסוריאזיס
ג. cyclosporine - נשירת שיער
ד. anti-TNF - היפונתרמיה

56. בת 23 סובלת מפריחת פרפר, ארתרלגיה עם נוקשות בוקר, כאבים פלאוריטים, אפטות בפה ואלופציה.. בבדיקות מעבדה: לויקופניה קלה, אנמיה קלה, הפטוגלובין לא מדיד, בדיקת direct Coombs חיובית, בדיקת ANA - חיובית, בדיקת נוגדנים ל - dsDNA - חיובית. ערכי C3-4 נמוכים. תפקודי כליה תקינים. איזו בדיקה נוספת **חובה לבצע?**

א. קפילרוסקופיה של מיטת הציפורן
ב. בדיקת שתן כללית
ג. אולטראסאונד כליות
ד. בדיקת מח עצם

57. מה נכון לגבי מעורבות כלייתית בסקלרודרמה?

א. היא גורם התמותה מספר אחד
ב. עד 2/3 מהחולים עם scleroderma renal crisis יזדקקו לדיאליזה
ג. הסיכוי לפתח scleroderma renal crisis גבוה במיוחד במטופלות עם anti-centromere חיובי
ד. הסיכוי לפתח scleroderma renal crisis עולה ככל שהמחלה ממושכת יותר

58. בן 81, פונה לטיפול בשל התקפי פרפור עליות תסמיניים. ברקע מחלת לב כלילית עם HFrEF וקוצר נשימה קל בפעילויות היום-יום. מה ההצהרה הנכונה לגבי הטיפול בפרפור העליות של חולה זה?

א. flecainide הוא טיפול קו ראשון
ב. dronedarone הוא טיפול קו שני
ג. propafenone בשילוב חסמי בטא הוא טיפול קו שני
ד. אבלציה של ורידי הריאה היא טיפול קו ראשון

59. בן 62 מאושפז במחלקה האורתופדית לאחר ניתוח החלפת ברך שמאל. ביום השני לאחר הניתוח מתלונן על כאב בחזה וקוצר נשימה. בבדיקתו טאכיקרדיה ודה-סטורציה. מה מהבאים נכון לגבי אבחנה של תסחיף ריאתי <u>במקרה זה</u>?

א. בדיקת d-dimer בערכים תקינים (על פי הגיל) יכולה לשמש כבדיקת 'rule out'
ב. בהיעדר זמינות של בדיקת CTA, אקו לב המדגים תפקוד תקין של חדר ימין שולל אבחנה של תסחיף ריאתי
ג. הרחבת חדר ימין בבדיקת CTA מנבאת שיעור תמותה מוגבר בתוך 30 יום
ד. תבנית אק"ג אופיינית 'S1Q3T3', היא רגישה וספציפית לאבחון acute PE

60. בן 35, לפני שבועיים מחלת חום וכאב גרון, בשל כך טופל ב amoxicillin עם רזולוציה של הסימפטומים. כעת, הופעת בצקות בגפיים תחתונות. בבדיקתו – ל"ד 170/100, בצקות גומתיות בשתי השוקיים. בסרום עליית קריאטינין ל-1.7 מ"ג/ד"ל מבסיס של 0.9 מ"ג/ד"ל. בשתן – המטוריה ופרוטאינוריה. באיסוף שתן הפרשה של 1.5 גרם חלבון ליממה. מה הטיפול <u>המקובל</u> במחלתו הסבירה ביותר?

א. חידוש הטיפול האנטיביוטי ב- amoxicillin
ב. התחלת טיפול אנטיביוטי ב- amoxicillin-clavulanate
ג. התחלת טיפול ב- prednisone 1mg/kg
ד. טיפול תומך ע"י furosemide, ACE inh וכו'

61. איזה מבין הבאים מהווה גורם סיכון להתפתחות Crohn`s disease?

א. גלולות למניעת הריון
ב. כריתת תוספתן
ג. מוצא לטיני
ד. הימנעות מעישון

62. בן 75, התקבל למלר"ד בתמונה של חולשת פלג גוף שמאל ודיסארתריה אשר החלו 3 שעות טרם קבלתו. בבדיקתו ל"ד 200/100. תוצאות CT מח מצורפות **(תמונה 11)** . בהינתן שהמטופל לא מועמד לטיפול טרומבוליטי (תרופתי או מכני) או כירורגי– כיצד יש לטפל בו כעת?

א. יש להפחית את לחץ הדם הסיסטולי לערכים נמוכים מ- 180 מ"מ כספית תוך 24 שעות
ב. אין כעת צורך בטיפול ביתר לחץ דם
ג. יש להפחית את לחץ הדם הסיסטולי לערכים פחות מ- 140 מ"מ כספית תוך 24 שעות
ד. יש להפחית את לחץ הדם הסיסטולי לערכים נמוכים מ- 180 מ"מ כספית תוך 4 שעות

63. איזה מבין הבאים היא גישה טיפולית מקובלת כיום במקרים של בקטרמיה ע"י *pseudomonas aeruginosa* בחולה שאיננו נויטרופני?

א. IV cefepime 2g x 3/d למשך 14 ימים
ב. IV amikacin 15 mg/kg x 1/d למשך 7 ימים
ג. IV cetazidime 2g x 3/d למשך 7 יום
ד. IV meropenem 1 g x 3/d למשך 14 יום

64. איזה מבין הבאים הוא הפרוטוקול הטיפולי בסטרואידים באבחנה של מנינגיטיס פנאומוקוקלית חיידקית?

א. IV dexamethasone 10 mg x 2/d for 4 days
ב. IV dexamethasone 10 mg x 4/d for 4 days
ג. IV hydrocortisone 50 mg x 3/d for 7 days
ד. IV hydrocortisone 100 mg x 3/d for 7 days

65. בת 38, חסרת בית, מובאת למלר"ד מעורפלת הכרה, חבריה מדווחים כי חולה כבר למעלה משבוע. בבדיקתה: סטופורוטית, ללא קישיון עורף ללא חסרים נוירולוגיים מוטוריים או הפרעה בעיצבוב קרניאלי. לחץ הדם 80/50 ממ"כ, דופק 120 סדיר, חום 39.2^0C, 22 נשימות לדקה וסטורציה של 92% באוויר החדר. כפות הידיים נראות **בתמונה 12**. מה הטיפול האמפירי במחלתה הסבירה ביותר?

א. doxycycline + vancomycin
ב. meropenem + vancomycin
ג. penicillin + ceftazidime
ד. vancomycin + clindamycin

66. בת 75, פונה למרפאה בשל כאבי מפרקים בכפות ידיים מזה מספר חודשים. הכאבים מוחמרים בהפעלה ומוקלים במנוחה, יש נוקשות בוקר של כ- 5 דקות. סרולוגיה כולל RF, anti CCP, ANA שלילית. מדדי דלקת תקינים. בבדיקתה נצפים הממצאים בתמונה המצורפת. כיצד מכונים הממצאים על פני ה- DIP'S **(תמונה 13)**?

א. Bouchard's nodes
ב. Guttron papules
ג. Swan neck deformity
ד. Heberden's nodes

67. מה סיבת התמותה השכיחה ביותר בחולי rheumatoid arthritis (RA)?

א. מחלה זיהומית
ב. מחלת לב איסכמית
ג. מחלת ריאות אינטרסטיטיאלית
ד. ממאירות סולידית או המטולוגית

68. מה המחלה הסבירה ביותר ממנה סובל המטופל שמשטח הדם שלו מצורף ב**תמונה 14**?

א. Myelodysplastic syndrome
ב. Myelofibrosis
ג. Thalassemia
ד. Sickle cell disease

69. בכל המחלות הבאות צפויה להמצא הגדלה של הטחול **פרט ל**:

א. Polycythemia vera
ב. Myelofibrosis
ג. Immune thrombocytopenic purpura
ד. Hemophagocytic lymphohistiocytosis

70. בת 51, ברקע אטופיה ואסתמה מספר שנים. מטופלת במשאף ומאוזנת. בשבועות האחרונים חום סבפיברילי והחמרה ניכרת בקוצר הנשימה ללא שיפור תחת המשאף הקבוע. בבדיקות דם בקהילה WBC 5100, לימפוציטים 1000, נויטרופילים 2400, אאוזינופילים 1700, קריאטינין ואנזימי כבד תקינים, CRP מוגבר. בוצעו שני צילומי חזה בחודש האחרון ונמצאו תסנינים תת פלאורליים פריפריים מיגרטוריים. איזה מבין הבאים נכון בסבירות גבוהה לגבי מחלתה?

א. על פי רוב נדרשת אבחנה היסטולוגית
ב. במיעוט החולים קיימת אאוזינופיליה פריפרית
ג. שכיח (נפוץ) למצוא אאוזינופיליה בשטיפה ברונכיאלית
ד. ברוב החולים קיימת מעורבות של מערכות נוספות מלבד מערכת הנשימה

71. בן 65, ברקע סוכרת, יתר לחץ דם ואי ספיקת לב. מאושפז בשל קוצר נשימה. בבדיקה ובצילום חזה נמצא תפליט פלאורלי גדול מימין. החולה עובר ניקור פלאורלי ובבדיקות המעבדה נמצא:

	דם	נוזל פלאורלי
LDH	380	200
Protein	6.8 g/dl	3.5 g/dl
Glucose	120 mg/dl	100 mg/dl

לאור תוצאות אלו מה הצעד הבא הנדרש להמשך בירור האתיולוגיה של נוזל זה?

א. אין צורך בהמשך בירור וניתן להניח שהסיבה היא אי ספיקת לב
ב. יש לבצע CT חזה בקרינה נמוכה
ג. יש לבצע CTA של עורקי הריאה
ד. יש לשלוח את הנוזל לבדיקה ציטולוגית

72. בן 25, ברקע ulcerative colitis המערבת את כל המעי הגס. מאושפז בשל התלקחות מחלתו עם שלשול דמי מרובה וכאבי בטן. בבדיקתו נראה כאוב, ל"ד 130/90, דופק 100, ללא חום, בבדיקת הבטן - תפוחה, רגישות דיפוזית למישוש, ללא סימני גירוי פריטונאלי. בצילום בטן ריק - קולון מורחב, עם קוטר של 7 ס"מ בקולון ימני. כיצד יש לטפל בחולה זה?

א. ישנה התוויה לניתוח לפרוסקופי דחוף
ב. ישנה התוויה לניתוח פתוח דחוף
ג. יש להתחיל בטיפול שמרני תחת מעקב צמוד
ד. יש לבצע קולונוסקופיה דחופה לדה-קומפרסיה של המעי

73. מה נכון לגבי הטיפול בחולים הסובלים מ- hypertrophic cardiomyopathy?

א. בהעדר קונטרה אינדיקציה כל חולה הסובל מפרפור עליות זקוק לטיפול באנטיקואגולציה
ב. digitalis הוא טיפול הבחירה להאטת קצב בחולים עם פרפור עליות
ג. hydralazine הוא טיפול הבחירה לאיזון יתר לחץ דם
ד. בחולים הזקוקים ל- ICD מומלץ להשתיל קוצב משולב עם ICD

74. איזה מבין המצבים הבאים מהווה קונטרה אינדיקציה למתן חסמי ביתא לחולים המאושפזים בשל acute NSTEMI ועדיין סובלים מכאב בחזה?

א. PR interval of 0.22 sec
ב. Pulmonary edema
ג. Chronic COPD
ד. Heart rate of 60 bpm

75. איזה מבין הבאים עלול לגרום ל- secondary mitral regurgitation?

א. Rheumatic fever
ב. Atrial fibrillation
ג. Carcinoid tumor
ד. Left ventricular hypertrophy

76. מאיזו מחלה (בסבירות הגבוהה ביותר) סובל המטופל שצילום החזה שלו מוצג **בתמונה 15**?

א. חסם הולכה עלייתי חדרי מדרגה שלישית
ב. אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור
ג. סינדרום ברוגדה
ד. אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד

77. בן 62, מאושפז בשל זיהום בדרכי השתן. בתרבית דם צמיחה של E. coli ESBL. לאיזו תרופה אנטיביוטית הכי סביר שהחיידק יהיה רגיש?

א. Piperacillin-tazobactam
ב. Cloxacillin
ג. Ceftazidime
ד. Aztreonam

78. איזה סיבוך **אופייני** לחולי מיאלומה נפוצה המטופלים ב- IMiDS כגון lenalidomide ו- dexamethasone?

א. Fungal infections
ב. Hypercoagulability
ג. Acute kidney injury
ד. Capillary leak syndrome

79. בן 58, בריא בד"כ, ללא אנמנזה של עישון או שתיית אלכוהול, מאובחן כסובל מ- essential thrombocytosis שהתגלה בבדיקות דם שגרתיות. מס' טסיות – 900,000. מה נכון לגבי הצורך בטיפול בחולה זה?

א. יש לטפל על מנת למנוע התפתחות של לוקמיות משניות
ב. אין צורך בטיפול – מעקב בלבד
ג. יש לטפל רק אם לחולה מוטציה ב- JAK2
ד. יש לטפל על מנת למנוע אירועים טרומבוטים

80. נקראת לייעץ לגבי מטופלת כבת 80 המאושפזת במחלקה האורטופדית לאחר ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך, עקב הופעה של היפוקסמיה אקוטית. ניסיון תיקון ההיפוקסמיה ע״י מתן חמצן בריכוז 100% הביא לשיפור קל בלבד. לדברי החולה היא משתעלת שיעול סמיך מתקשה לכייח ולפנות הפרשות. במסגרת הבירור בוצע צילום חזה **(תמונה 16)**. איזה מבין התהליכים הבאים יסביר בסבירות גבוהה את ההיפוקסמיה?

א. Hypercarbia
ב. V/Q mismatch
ג. shunt (Right to left)
ד. Low A-a gradient

81. בת 26, מזה שנים שיעול כרוני עם פליטת ליחה. בירור ל- cystic fibrosis – שלילי. תפקודי נשימה הראו הפרעה חסימתית בינונית ללא שיפור לאחר טיפול במרחיבי סימפונות. בוצעה בדיקת CT **(תמונה 17)**. איזה מבין הטיפולים הבאים יסייע לה, כעת כשהיא במצבה הבסיסי, בצורה הטובה ביותר?

א. אינהלציות של DNAse
ב. אינהלציות של מי מלח מרוכזים ופיזיוטרפיה נשימתית
ג. טיפול קבוע במאקרולידים
ד. אינהלציה של קוליסטין

82. בן 82, מטופל ב- nivolumab לממאירות ריאתית. מאושפז בשל חולשה, לחץ דם נמוך והיפוגליקמיה. ללא חום. אתה חושד בתופעת לוואי של הטיפול האונקולוגי. מה יבדיל בין פגיעה מרכזית (ראשונית) לפריפרית (שניונית)?

א. היפונתרמיה
ב. היפרקלמיה
ג. היפומגנזמיה
ד. היפוקלצמיה

83. איזה מאפיין קליני ניתן למצוא בבדיקתו של מטופל המאובחן כסובל פאוכרומוציטומה?

א. אודם בפנים
ב. הכרה ירודה על רקע של היפוגליקמיה
ג. תת לחץ דם אורטוסטטי
ד. שלשול

84. למי מבין המטופלים הבאים צפוי להיות ה- pulse pressure הגבוה ביותר?

א. בן 72, ברקע peripheral a disease קשה
ב. בת 85, ברקע severe aortic stenosis
ג. בן 52, ברקע hypertrophic obstructive cardiomyopathy
ד. בת 80, ברקע hypothyroidism

85. בן 70, ברקע ידוע על HFrEF. בשבוע האחרון מקיא. בבדיקתו נראה במצוקה ומתנשם. בבדיקות המעבדה:

גזים		**כימיה**	
7.58	pH	127 מא"ק/ל	Na
20 מא"ק/ל	HCO_3	5.2 מא"ק/ל	K
21 מ"מ כספית	PCO_2	79 מא"ק/ל	Cl
		1.8 מ"ג/ד"ל	Creatinine
		4 ג'/ד"ל	Albumin

מהי הפרעת החומצה בסיס של המטופל?

א. בססת נשימתית עם פיצוי מטבולי הולם
ב. normal anion gap metabolic acidosis עם בססת נשימתית
ג. high anion gap metabolic acidosis בשילוב עם בססת נשימתית ובססת מטבולית
ד. high anion gap metabolic acidosis עם בססת נשימתית

86. בישיבת הבוקר מוצגת חולה שאושפזה בשל תלונות ממושכות של ירידה במשקל, צואה שומנית וחולשה. כעת הופנתה למלר"ד בשל ממצא של אי ספיקת כליות חדה בבדיקות דם בקהילה. במלר"ד בוצע CT שהדגים גם את הממצאים הבאים **(תמונה 18)**. מה המחלה ממנה סובלת המטופלת בסבירות גבוהה ?

א. Carcinoma of pancreas
ב. MEN1 syndrome
ג. IgG4 related disease
ד. Takayasu's arteritis

87. איזה מצב מבין הבאים הוא סיבוך אופייני יותר לדיאליזה פריטונאלית מאשר להמודיאליזה?

א. היפרקלמיה
ב. היפרפוספטמיה
ג. היפרגליקמיה
ד. היפרפרוטאינמיה

88. בת 70, אושפזה עקב שלשול וחום. בדיקת צואה הייתה חיובית ל toxin *clostridioides difficile*. המטופלת לא נטלה לאחרונה טיפול אנטיביוטי. איזו תרופה אותה נוטלת המטופלת באופן קבוע עלולה לגרום לכך?

א. Esomeprazole
ב. Acetylsalicylic acid
ג. Magnesium oxide
ד. Clopidogrel

89. איזה סיבוך מבין הבאים עשוי להימנע על ידי מתן מנת דם מוקרנת?

א. TRALI (Transfusion-related acute lung injury)
ב. Febrile non hemolytic transfusion reaction
ג. Alloimmunization
ד. GVHD (graft versus host disease)

90. בן 75 מעשן כבד. מתלונן על קוצר נשימה פרוגרסיבי ושיעול יבש. בבדיקתו רזה, סטורציה 97% באוויר החדר אך 91% לאחר מאמץ. חרחורים אינספירטורים דו צדדיים בבסיסי הריאות. קולות הלב תקינים ללא אוושות, ללא בצקות היקפיות, ללא סימני ארטריטיס. Clubbing ניכר בכפות הידיים.
בבדיקת HRCT חזה – נצפו הצללות רשתיות דו"צ בעיקר באזורים סאבלפלאורלים ובבסיסי הריאות עם סימני חלת דבש (honeycombing) וברונכיאקטזיות משיכה (traction bronchiectasis).
איזו תוצאת תפקודי נשימה שייכת למטופל בסבירות הגבוהה ביותר?

	FEV1	FVC	FEV1/FVC	TLC	RV	DLCO
א	55%	72%	65%	102%	110%	60%
ב	91%	84%	105%	84%	89%	43%
ג	72%	95%	68%	122%	141%	98%
ד	58%	59%	91%	69%	75%	42%

91. איזה מהביטויים הקליניים הבאים **פחות אופייני** ל - West Nile virus?

א. Meningitis
ב. Encephalitis
ג. Flaccid paralysis
ד. Transverse myelitis

92. בן 65, מאושפז בשל דמם ספונטני לרטרופריטונאום. ב- CT ללא בעיה אנטומית המסבירה את הדמם. ספירת דם תקינה למעט ירידה בהמוגלובין, PT תקין, PTT מוארך ללא תיקון לאחר מבחן ערבוב עם פלסמה. מה הסיבה הסבירה ביותר לדמם?

א. חסר פקטור VIII
ב. נוגדנים לפקטור VIII
ג. חסר פקטור VII
ד. נוגדנים לפקטור VII

93. בן 82, מאושפז בשל בצקות שהולכות ומחמירות. עוד ברקע - סינדרום התעלה הקרפלית שנותח בשתי הידיים. בבירור ראשוני מבוצעים אק״ג ואקו לב (**תמונות 19 ו- 20**). במיפוי 99Tc pyrophosphate (bone scintigraphy) קליטה חזקה ודיפוזית בשריר הלב. מה הטיפול המומלץ בחולה זה?

א. Daratumumab
ב. Colchicine
ג. Tafamidis
ד. Dialysis

94. בן 18, מגיע למלר״ד בשל פריחה נודדת שהופיעה ב- 24 שעות האחרונות (**תמונה 21**). שולל קוצר נשימה. בבדיקתו יציב המודינמית. מה הטיפול המומלץ?

א. סטרואידים פומיים
ב. סטרואידים תוך ורידיים
ג. אנטיהיסטמינים פומיים
ד. חסמי H2

95. איזו מבין התרופות הבאות עלולה לגרום ל- serotonin syndrome במתן במינון יתר משמעותי?

א. Baclofen
ב. Tramadol
ג. Salicylates
ד. Antihistamines

96. כל הטיפולים התרופתיים הבאים **מאטים** את קצב ההתקדמות של מחלת כליה כרונית בחולי סוכרת סוג2, **פרט ל:**

א. Glucagon like peptide1 (GLP1) receptor agonists
ב. DPP4 inhibitors
ג. Mineralocorticoid receptor antagonists
ד. SGLT2 inhibitors

97. בת 55 עם CKD-stage 5 נותנת כ-1500 מ״ל שתן ליממה ועדיין לא התחילה דיאליזה. עברה בדיקת קולונוסקופיה כהכנה לקראת השתלת כליה. יומיים לאחר מכן מגיעה למלר"ד עקב חולשה ואנוריה. בבדיקות המעבדה:

		כימיה	
10 מ״ג/ד״ל	Creatinine	131 מא״ק/ל	Na
250 מ״ג/ד״ל	Urea	5.9 מא״ק/ל	K
3.5 ג׳/ד״ל	Albumin	5.3 מ״ג/ד״ל	Ca
		15 מ״ג/ד״ל	P

איזה מבין הבאים הוא האתיולוגיה הסבירה ביותר למצבה?

א. שלשול מרובה במהלך היממה שלפני הקולונוסקופיה
ב. ATN כתוצאה מתת-לחץ דם עקב סדציה עם דורמיקום ופנטניל
ג. הכנה לקולונוסקופיה עם Fleet enema
ד. הפסקת אכילת חלבון וירקות ושתיית נוזלים צלולים בימים שטרם הקולונוסקופיה

98. למי מהמטופלים הבאים מתאימות הבדיקות הללו:
serum [K] – 2.8 meq/l, urine [K] – 35 meq/l, urine [Na] – 120 meq/l

א. מטופל עם אנדוקרדיטיס המטופל מזה שבוע ע״י IV cloxacillin
ב. מטופל עם hyperosmolar state שהתחיל לקבל אינסולין דרך הוריד
ג. מטופל עם חום נויטרופני שמקבל יומיים GCSF
ד. מטופל עם קושי ממושך באכילה אחרי הקרנות לצוואר, שהחל לקבל TPN לפני 3 ימים

99. בן 35, ברקע rheumatoid arthritis לא מטופל. בבדיקות הדם שלו התפתחות של אנמיה עם המוגלובין 8.4 gr/dl ו-MCV 80fl, ספירת רטיקולוציטים 1.1%. איזה מהבאים מסביר את הפתוגנזה של האנמיה של חולה זה?

א. ירידה ברמות hepcidin מדכאות ספיגת ברזל מהמעי ומזרזות יציאת ברזל מהפטוציטים וממקרופאג'ים
ב. ירידה ברמות hepcidin מזרזות ספיגת ברזל מהמעי ומעכבות יציאת ברזל מהפטוציטים וממקרופאג'ים
ג. עליה ברמות hepcidin מדכאות ספיגת ברזל מהמעי ומזרזות יציאת ברזל מהפטוציטים וממקרופאג'ים
ד. עליה ברמות hepcidin מדכאות ספיגת ברזל מהמעי ומעכבות יציאת ברזל מהפטוציטים וממקרופאג'ים

100. בת 46 מאובחנת מס' שנים עם MGUS, מפתחת נוירופתיה פריפרית בחצי שנה אחרונה עם עייפות משמעותית וללא תלונות נוספות. בבדיקתה - הירסוטיזם. במעבדה ללא אנמיה או היפרקלצמיה, אבל טרומבוציטוזיס של 620,000. רמת M-Protein יציבה של 0.5 gr/dl ובבדיקת TSH נמצאו ערכים נמוכים. סקר שלד – נגעים סקלרוטים. מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. Primary Systemic Amyloidosis
ב. POEMS syndrome
ג. MGUS related neuropathy
ד. Cryoglobulinemia

בהצלחה!